

PLANTEAMIENTO PARA LA REORGANIZACIÓN DE ESSALUD

Del diagnóstico en cifras a la decisión con responsable

Propuesta técnica elaborada con el Modelo de Excelencia GEMSES

Mg. Carlos Pérez Pérez

Magíster en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

Investigador RENACYT · ORCID 0000-0001-8425-1875

Lima, Perú — agosto de 2026 · Versión 1.0

Nota metodológica: la regla de este documento

Toda cifra de este planteamiento tiene fuente primaria identificada al nivel de documento, página, lámina o artículo, y está registrada en una base de datos verificable (essalud_diagnostico.db: 16 tablas, 9 fuentes primarias, 181 cifras trazadas). Los análisis — series financieras, duplicidad normativa, brecha territorial — son reproducibles: los scripts, umbrales y archivos fuente acompañan al documento. La regla es una sola: un problema sin dato no entra; un dato que no termina en una decisión con responsable, tampoco.

Fuente primaria	Qué aporta
EsSalud – Evaluación Presupuestal, Formato 4E/5E remitido al FONAFE, cierres 2016-2024 (essalud.gob.pe/informacion-presupuestal)	Serie oficial de ejecución: ingresos, egresos, personal, inversión, resultado económico
EsSalud – Diagnóstico Situacional presentado por la Presidencia Ejecutiva al MTPE, nov-2025 (118 láminas)	Flujo de caja 2023-2029, deuda, RR.HH., producción, abastecimiento, equipamiento
EsSalud – Plan Estratégico Institucional 2026-2030 (Acuerdo CD 11-12E-ESSALUD-2025)	39 indicadores oficiales con línea de base 2025 y metas 2026-2030
EsSalud – ROF, texto concordado (RPE 656-2014 hasta RPE 1183-PE-ESSALUD-2025) + 15 ROF desconcentrados + 6 ROF tipo de establecimientos	87 órganos y 1,018 funciones del nivel central; inventario normativo completo
EsSalud / Banco Mundial – Libro Blanco (2019), tomos 1 y 2	Brecha de inversión a 2035, sostenibilidad, gasto de bolsillo
OIT – Estudio Financiero Actuarial EsSalud 2022; Evaluación de la gestión institucional (2024); encuesta a 20,265 trabajadores (2024)	Escenarios de ingresos, diagnóstico macro/meso/micro, clima y percepción
SUSALUD – RENIPRESS	408 IPRESS EsSalud activas, categorías y camas
INEI – Censos Nacionales 2025 (tema: seguro de salud)	Personas que declaran afiliación a EsSalud, por departamento

PRIMERA PARTE — El diagnóstico en trece cifras

1. La tesis

EsSalud no está quebrada: está sin colchón, sin conteo y sin responsables. Son tres carencias distintas que se refuerzan entre sí, y por eso las reformas parciales fracasaron: el Reglamento de Organización y Funciones del nivel central se modificó dieciocho veces desde 2014 — una vez cada 7.3 meses — sin que ningún indicador de resultado cambiara de tendencia. Este planteamiento ataca las tres carencias a la vez.

2. Los trece problemas, cada uno con su cifra

#	Problema	La cifra que lo prueba	Fuente
1	Sin colchón financiero	Saldo de caja: de 7.4 días de operación (2023) a 1.0 día en 2026; flujo económico negativo en 2025 (-S/ 90 MM) y 2026 (-S/ 105 MM)	Flujo de caja institucional 2023-2029
2	Resultado real oculto	Resultado económico negativo en 6 de 9 años (2016-2024); 2024 cerró en cero consumiendo S/ 1,053 MM de ejercicios anteriores	Formato 4E/5E FONAFE
3	Dos contabilidades del mismo año	2024: +S/ 899 MM de superávit en un documento oficial y -S/ 186 MM en otro; S/ 1,023 MM de diferencia en el gasto	Diagnóstico PE vs Formato 5E
4	Costo unitario fuera de control	Elasticidad gasto/asegurados = 2.82; gasto per cápita +15.5 % a 2029	Cálculo sobre serie oficial
5	Se gasta en operar, no en transformar	Inversión: 3.6 % del gasto, con la peor ejecución del presupuesto (58.4 %); gasto en terceros +70 % sobre el nivel prepandemia	Ejecución 2025; Formato 4E/5E
6	Brecha de capacidad congelada	S/ 31,226 MM a 2035; al ritmo del presupuesto 2026 se cierra en 51.6 años	Libro Blanco 2019 + presupuesto 2026
7	No se sabe cuánto se tiene ni a quién se cubre	401 / 393 / 408 establecimientos según la fuente; padrón de 12.76 M vs 8.12 M que declaran afiliación en el Censo 2025: 4.6 millones en disputa	PE; RENIPRESS; Censo INEI 2025
8	Equipamiento parado	Solo 20 de 63 tomógrafos rinden por encima del 75 %; equipamiento biomédico operativo 40.5 % y la meta 2030 es 43 %: la meta acepta el problema	PE; PEI ficha AEI 1.2.4
9	Personal: brecha tapada, no cerrada	Brecha de 18,685 plazas (29.4 % de la planilla) cubierta a medias con 9,955 locadores; satisfacción con el clima laboral: 25 %	PE; PEI ficha OEI 4.1
10	Acceso racionado por espera	Diferimiento de citas 25.94 días; 66.1 % de pacientes quirúrgicos aptos espera más de 45 días; tamizaje de cáncer de mama en 14.4 % frente a una meta de 35 %	PE; PEI ficha AEI 1.2.3
11	Logística que falta y sobra a la vez	1,539 ítems agotados y 5,386 en sobrestock (cobertura mayor a 4 meses), simultáneamente	PE, abastecimiento nov-2025
12	Estructura duplicada y sin dueño del resultado	273 pares de funciones solapadas entre órganos; tres órganos con diez funciones idénticas palabra por palabra; 78.2 % de los órganos sin ningún indicador en el PEI	ROF 2025 + PEI (análisis propio)
13	Normas de dos épocas distintas	ROF central: 9 meses de antigüedad; ROF de redes: mediana de 13 años y nombran gerencias que ya no existen; el ROF tipo de los Policlínicos es de 1992 (IPSS, siete años ANTES de crearse EsSalud) y los de Hospitales I/II/III de 2007-2008; las 4 redes prestacionales no tienen ROF	Inventario de 21 ROF oficiales

3. La convergencia que vuelve esto urgente

Tres diagnósticos independientes, con metodologías distintas, señalan la misma ventana temporal: el Banco Mundial (Libro Blanco, 2019) proyectó un déficit operacional creciente hacia 2028; la OIT (Estudio Financiero Actuarial 2022) advirtió que incluso aplicando todas las medidas propuestas los déficits reaparecen desde 2026; y la propia proyección institucional (2025) muestra flujo económico negativo exactamente en 2025-2026, con la caja en un día de operación. 2026 no es una lectura interesada: es la intersección de los tres informes.

4. La prueba de que sí se puede

Cuando la institución midió y priorizó, ejecutó: el desembalse quirúrgico pasó de 32,528 pacientes en lista (noviembre de 2023) a 455 pendientes (98.6 %), con 22 de 29 redes en cero. La capacidad de ejecutar existe. Lo que no existe es el mecanismo que la active de forma permanente. Eso — y no un organigrama nuevo — es lo que este planteamiento instala.

SEGUNDA PARTE — El planteamiento en seis ejes

Eje 1 · Reorganización estructural: menos órganos, cada uno con un resultado

- **Nivel central:** de 13 gerencias centrales a 8 unidades ordenadas por macroproceso GEMSES (Estratégico 2, Misional 3, Soporte 3).
- **Fusiones inmediatas:** cuatro fusiones que la duplicidad literal ya probó — los tres órganos de atención al asegurado (arts. 139/140/141 del ROF, diez funciones idénticas), las dos gerencias de promoción de inversiones (arts. 134/135, trece de catorce funciones idénticas), los órganos de control (arts. 20/22/24) y la asesoría jurídica (arts. 59/60). Resultado: -6 órganos y -6 planillas directivas.
- **Cascada normativa única:** ROF central + reglamento tipo de red + reglamento tipo por categoría de establecimiento, aprobados y actualizados juntos. Hoy el centro se reformó 18 veces mientras el nivel desconcentrado conserva reglamentos de 2007 a 2018 que ordenan reportar a gerencias que ya no existen — y los establecimientos operan con reglamentos tipo de 2007-2011, incluido el de Policlínicos, aprobado por el IPSS en 1992: siete años antes de que EsSalud existiera.
- **ROF de red real:** cada red recibe un anexo real (cartera, dotación, metas) en lugar de la plantilla de 2010: hoy los ROF de dos redes comparten al menos el 19 % del texto palabra por palabra. Las 4 redes prestacionales, sin ROF propio, entran a la norma con capítulo propio.
- **Sin relleno:** las obligaciones transversales (control interno, gestión de riesgos) se escriben una sola vez en un título general: hoy una misma cláusula se repite en 47 órganos.

Eje 2 · Jefaturas por resultados: el corazón del planteamiento

La secuencia probatoria: el ROF crea estructura sin responsabilidad (21 % de su texto es cláusula repetida) → hay duplicidad literal (cuando tres órganos firman lo mismo, ninguno responde) → el 78.2 % de los órganos no tiene resultado medible en el PEI → y donde se midió y priorizó (desembalse quirúrgico), se cumplió. Conclusión: la unidad de la reforma no es el organigrama; es el contrato de gestión.

- **Contrato de gestión:** máximo 5 indicadores por jefatura, todos con línea de base verificable en el PEI o el ESSI (los 39 indicadores oficiales ya están clasificados KPI/KRI/KCI), meta trimestral y consecuencia publicada antes de la evaluación: continuidad, bono o cese.
- **Tablero único:** una sola fuente de datos alimenta el tablero de todos; se elimina el reporte manual, que hoy es costo y coartada a la vez.
- **Designación:** concurso con requisitos del Manual de Puestos; la permanencia se gana con el indicador. Contexto que lo exige: 12 presidentes ejecutivos en cinco años, y cada relevo arrastra rotación gerencial en cascada.
- **Piloto:** 180 días en las 8 redes en riesgo crítico del índice territorial (INCOR, Tarapoto, Loreto, Almenara, Ucayali, Tumbes, Madre de Dios, Moyobamba), con grupo de comparación. Una reforma que no se puede evaluar es indistinguible de una que no funciona.

Eje 3 · El dato como columna vertebral

Tres números demuestran que no existe una sola verdad institucional: tres conteos de establecimientos (401/393/408), dos resultados financieros del mismo año (+899/-186) y dos universos de asegurados (12.76 M del padrón frente a 8.12 M que declaran afiliación en el Censo 2025).

- **Auditoría censal del padrón:** cruce padrón × Censo × RENIEC para resolver los 4.6 millones en disputa. Es la primera decisión porque todo denominador depende de ella. Si el uso se mide contra quienes se reconocen asegurados, la extensión de uso sube de 52.9 % a ~83 %: el diagnóstico cambia de 'la gente no viene' a 'el padrón no es real'.
- **Inventario único:** una sola cifra oficial de establecimientos, camas y equipos, conciliada con RENIPRESS (hoy solo 301 de 408 IPRESS declaran camas), con un dueño institucional.
- **Una sola contabilidad de gestión:** conciliación formal y pública entre la ejecución presupuestal (FONAFE) y los estados financieros, con explicación de cada brecha; la línea 'resultado de ejercicios anteriores' deja de amortiguar en silencio.
- **Indicador del eje:** el Índice de Madurez en Gobernanza y Calidad de Datos ya existe en el PEI (línea de base 0.52 sobre 5.00): se adopta como indicador del contrato de gestión de la unidad de datos.

Eje 4 · Desburocratización con evidencia

El registro interno de eventos de seguridad del paciente del primer trimestre de 2025 es la radiografía del problema: de 535 fichas ingresadas se anularon 499 (93.3 %), 453 de ellas por erróneas. Un sistema que descarta nueve de cada diez notificaciones no está midiendo la seguridad del paciente: está midiendo la mala calidad de su propio formulario. Los 36 eventos validados (11 con desenlace de muerte) equivalen a 2.8 por millón de asegurados por trimestre — una tasa que ningún estándar internacional considera verosímil: es subregistro.

- **Regla de una página:** todo formato asistencial que no quepa en una pantalla se rediseña o se elimina; la validación ocurre en el punto de captura, no en la depuración posterior.
- **Modelo de ahorro:** caso de referencia INCOR (eliminación de formatos con ahorro estimado de S/ 2 MM en 90 camas): al confirmarse el sustento documental se extrapola a las 8,966 camas registradas con escenarios pesimista/central/optimista.
- **Indicadores del eje:** % de fichas válidas al primer intento (línea de base 6.7 %, meta > 90 %) y horas asistenciales liberadas de registro.

Eje 5 · Sostenibilidad financiera: primero eficiencia, luego ingresos

Por el lado del gasto — lo que EsSalud controla sin ninguna ley:

- **Logística:** planificación de demanda para eliminar la coexistencia de 1,539 ítems agotados con 5,386 en sobrestock: capital de trabajo inmovilizado mientras se suspenden procedimientos.
- **Bonificaciones:** la línea de bonificaciones (S/ 3,160 MM en 2024, 39.7 % del gasto de personal, +108 % desde 2016) no se recorta a ciegas: se condiciona al contrato de gestión del Eje 2. El régimen actual paga igual al que cumple y al que no.
- **Inversión:** la ejecución de gastos de capital (58.4 %, la más baja del presupuesto) pasa a ser indicador del contrato de la unidad de Logística e Infraestructura, con la meta del propio PEI (90 %).

Por el lado del ingreso — lo que requiere ley, con el sustento actuarial ya calculado:

- **Escenarios OIT:** los escenarios del Estudio Financiero Actuarial OIT 2022 aplicados a la proyección institucional suman +S/ 3,991 MM en 2026 (eliminar topes y estandarizar tasas: +7 %; restablecer la cotización sobre gratificaciones: +14 %). Equivale a 6.6 veces el presupuesto de inversiones de ese año.
- **Cobranza:** deuda a favor de EsSalud: S/ 5,327 MM (86.7 % ya exigible), de los cuales S/ 1,851 MM son del sector público; se respaldan los tres anteproyectos de ley ya aprobados por el Consejo Directivo.

Eje 6 · Tecnología al servicio de los cinco ejes

La tecnología no es un eje aparte: cada sistema se justifica por el problema medido que resuelve — tablero único (Eje 2), padrón auditado e inventario (Eje 3), formularios con validación en captura (Eje 4), planificación de demanda (Eje 5). Regla: ningún sistema nuevo sin el indicador de negocio al que sirve; la cartera existente de 85 proyectos digitales se filtra con ese criterio.

TERCERA PARTE — Hoja de ruta y riesgos

Horizonte 1 · Primeros 100 días (sin cambiar ninguna ley)

Acción	Entregable	Indicador de cumplimiento
Las 4 fusiones de duplicidad literal	Una RPE modificatoria	–6 órganos
Contratos de gestión en todas las gerencias centrales	Contratos firmados y publicados	100 % con indicador
Auditoría censal del padrón (fase 1: cruce masivo)	Informe con cifra conciliada	Brecha de 4.6 M explicada
Conciliación FONAFE ↔ estados financieros 2024	Informe público	Una sola cifra oficial 2024
Piloto de jefaturas por resultados en 8 redes críticas	Línea de base + metas a 180 días	Evaluación con grupo de comparación
Rediseño del formato de eventos de seguridad	Formato de una página en el ESSI	Fichas válidas > 60 %

Horizonte 2 · Primer año

Reglamento tipo de red con anexos reales por red (reemplaza los 15 ROF de 2007-2018); reglamentos tipo de establecimiento alineados a la categorización de RENIPRESS; tablero único en producción; extensión de los contratos de gestión a todas las jefaturas de red; presentación de los anteproyectos de ingresos con el sustento OIT.

Horizonte 3 · 2027-2030

Las metas ya existen — son las del PEI 2026-2030 —, lo que cambia es que ahora tienen dueño: diferimiento de 15 días; espera quirúrgica mayor a 45 días reducida a 43 %; equipamiento operativo con meta renegociada por encima del 43 % actual (que consolida el problema); clima laboral 70 %; ejecución de inversiones 90 %; madurez de datos 5.00.

Riesgos del planteamiento y su mitigación

Riesgo	Mitigación
La rotación de la alta dirección (12 presidentes ejecutivos en 5 años) se lleva la reforma	Los contratos de gestión y la cascada normativa son resoluciones publicadas: sobreviven al relevo. El piloto rinde evidencia en 180 días, dentro del horizonte de cualquier gestión
Resistencia a las jefaturas por resultados	El régimen premia con continuidad y bono a quien cumple; es el statu quo el que castiga el buen desempeño pagando S/ 3,160 MM de bonificaciones planas sin evaluación
La auditoría del padrón reduce la cifra oficial de asegurados	Sincerar el denominador mejora todos los indicadores de uso y focaliza el gasto donde existe derecho real; se comunica como saneamiento, no como pérdida
Cuestionamiento metodológico a los análisis	Todo es reproducible: fuentes, scripts y umbrales publicados; cualquier tercero puede repetir el cálculo y llegar al mismo número

Cierre

Los planteamientos que hoy circulan sobre EsSalud aciertan mayoritariamente en la tesis y fallan en la evidencia: cifras sin fuente, datos de gestiones pasadas y propuestas sin costo ni responsable. Este planteamiento se para en el mismo problema con otra base: 181 cifras trazadas a su documento de origen, 21 reglamentos descargados y medidos, 39 indicadores oficiales cargados con sus líneas de base, y una regla que no se negocia: un problema sin dato no entra; un dato que no termina en una decisión con responsable, tampoco.

Mg. Carlos Pérez Pérez

Magíster en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales · Investigador RENACYT

ORCID 0000-0001-8425-1875 · carlosperez100@gmail.com